

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de los Síndromes Positivo y Negativo (PANSS)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de los Síndromes Positivo y Negativo
Sigla	PANSS
Autores	Kay, S. R., et al.
Año	1987
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Desorganización cognitiva y conductual
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Entrevista clínica estructurada
Disponibilidad en español	Sí (Peralta & Cuesta, 1994)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No reproducir hoja, anclas ni manual.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Desorganización cognitiva y conductual. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Originalmente 3 escalas (Positiva, Negativa, Psicopatología General). Los análisis factoriales modernos derivan 5 factores, incluyendo "Desorganización" (conceptual, afecto inapropiado, pobre atención).

3 Características generales

Formato	Entrevista clínica estructurada
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	30 ítems en total.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Calificación clínica mediante escala Likert de 7 puntos (1 = Ausente, a 7 = Extremo) basada en entrevista y observación.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Originalmente 3 escalas (Positiva, Negativa, Psicopatología General). Los análisis factoriales modernos derivan 5 factores, incluyendo "Desorganización" (conceptual, afecto inapropiado, pobre atención).
Ítems	30 ítems en total.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Calificación clínica mediante escala Likert de 7 puntos (1 = Ausente, a 7 = Extremo) basada en entrevista y observación.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria por escalas.

Regla de corrección	Sumatoria por escalas.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuaciones continuas que reflejan la severidad de los síntomas en pacientes diagnosticados con esquizofrenia u otros trastornos psicóticos.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

El análisis factorial moderno extrae el factor "Desorganización" que cubre ambos constructos perfectamente (desorganización conceptual, pobre atención, etc).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	El análisis factorial moderno extrae el factor "Desorganización" que cubre ambos constructos perfectamente (desorganización conceptual, pobre atención, etc).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Peralta & Cuesta, 1994)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Desorganización cognitiva y conductual en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Kay, S. R., et al.; 1987.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Peralta & Cuesta, 1994)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Desorganización cognitiva y conductual
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 30 ítems en total.; Originalmente 3 escalas (Positiva, Negativa, Psicopatología General). Los análisis factoriales modernos derivan 5 factores, incluyendo "Desorganización" (conceptual, afecto inapropiado, pobre atención).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria por escalas.
Interpretación	Puntuaciones continuas que reflejan la severidad de los síntomas en pacientes diagnosticados con esquizofrenia u otros trastornos psicóticos.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Kay, S. R., et al. (1987). Escala de los Síndromes Positivo y Negativo.

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado.

<https://www.panss.org/>

<https://doi.org/10.1093/schbul/13.2.261>

<https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/positive-and-negative-syndrome-scale-for-schizophrenia>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	Listado español de 30 ítems y escala 1–7; el activo no contiene anclajes clínicos completos. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 4a3976f6eb92cf3e47c832e8e98 246 688b7bc97baeb75 790c5062d8d7d 2328cc.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Entrevista y observación clínica; requiere capacitación/manual.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	Listado español de 30 ítems y escala 1–7; el activo no contiene anclajes clínicos completos.
6. Periodo temporal	No verificado en el activo.
7. Escala/formato de respuesta	1–7, pero faltan definiciones completas de severidad.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntuaciones continuas que reflejan la severidad de los síntomas en pacientes diagnosticados con esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	NO COMPLETADAS: la nota local identifica posibles autores/titulares, pero en esta revisión no se confirmó una fuente primaria/legítima suficiente de la versión exacta. No fabricar referencias.
14. Decisión de QA	NO APTO PARA APLICACIÓN: faltan anclajes clínicos completos y manual de administración/puntuación.